

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La Couverture Sanitaire Universelle est un programme qui a encore du chemin à faire en Afrique subsaharienne particulièrement au Sénégal. L'atteinte des objectifs de l'ACMU nécessite la connaissance des déterminants de la couverture maladie, que ce soit payant (assurance médicale) ou gratuit (assistance médicale). Ce présent document s'est fixé comme objectif de pallier ce problème. Il s'est particulièrement penché sur les principaux déterminants de la couverture maladie, tout en prenant en compte l'interdépendance entre l'utilisation de gratuités et l'adhésion aux MS communautaires.

Dans le but de renforcer la connaissance des acteurs, l'étude s'est basée sur l'enquête EDS-Continue de 2017. Ainsi les déterminants utilisés dans ce mémoire sont d'une part liés à la demande de bien ou service et d'autre part à l'offre. L'approche demande comprend les caractéristiques individuelles mais aussi celles des ménages, alors que l'offre se penche sur les régimes et les modalités de paiement.

L'analyse descriptive univariée a été effectuée en regroupant les parties selon chaque approche. Dans l'analyse exploratoire il s'agissait de faire une ACM en prenant soin de changer les variables quantitatives en qualitatives. L'approche économétrique adoptée a conduit à l'estimation d'un modèle Probit bivarié avec deux équations simultanées à deux variables dépendantes.

Les variables les plus déterminantes de l'adhésion aux MS communautaires sont la taille du ménage, la zone de résidence, la région et l'indice de richesse. Cependant, d'autres variables comme l'âge du CM, le niveau d'éducation de l'enquêté et les modalités de paiement sont corrélées à l'adhésion, même si le modèle ne permet pas de les expliquer. Les gratuités quant à eux sont expliquées par les régimes de manière générale à savoir les MS communautaires, professionnelles, l'IPRES, les IMP. Par ailleurs, l'information qui consiste à savoir si l'individu a payé sa dernière consultation permet d'expliquer cette utilisation.

Les acteurs de la CMU sont encouragés à tirer parti des résultats de cette présente étude qui pourrait leur permettre de mieux orienter leurs actions en vue de l'amélioration des politiques de couverture maladie. A cet effet, les recommandations qui suivent sont formulées :

- Renforcer la visibilité des politiques de gratuité et des MS communautaires ;
- Insister sur l'accessibilité aux services dans les différentes zones et régions du pays ;

- Mettre l'accent sur le partage des informations sur les régimes proposées ;
- Soutenir davantage les populations les plus démunies.

En effet, les premiers résultats de l'analyse montrent l'utilisation très faible de la couverture maladie (au minimum 8 personnes sur 10 n'y adhèrent pas). En tant que pays en voie de développement, le Sénégal enregistre un taux élevé d'habitants dans le besoin (EDS-continue 2017). Or l'un des premiers objectifs de la CMU est de soutenir le monde rural et le secteur informel, néanmoins la classe des très pauvres est moins utilisateurs des gratuités. Ainsi, l'ACMU et ses partenaires se doivent de mieux informer la population sur les avantages que propose la couverture médicale. Dans cette même dynamique, l'accessibilité de certaines zones est très faible par rapport à la moyenne nationale. Des campagnes ciblées permettront à certaines régions de multiplier leur taux d'utilisation des services de la CMU. L'information sur les politiques de gratuités doit être mieux partagée dans le Sud du pays où les taux d'utilisation sont moins élevés. Par contre, partant du centre pour aller vers le Nord, l'accent est à mettre sur les MS communautaires et les autres régimes d'assurance médicale.

.